

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны проходить обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

1.2. Электротравма – это травма, полученная вследствие поражения человека электрическим током. При работе в кабинете информатики основные риски связаны с включением в электросеть компьютеров, принтеров и других технических средств, а также с возможностью возгорания аппаратуры.

1.3. Признаки электротравмы: расстройство деятельности центральной нервной системы, нарушение сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, потеря сознания, остановка дыхания и кровообращения, ожоги кожных покровов.

2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Первоочередная задача – как можно быстрее прекратить воздействие тока на пострадавшего, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть травмы .

2.1. При напряжении до 1000 В (стандартное напряжение в кабинете информатики)

Действие	Порядок выполнения
Отключение питания	Немедленно отключить электроустановку с помощью выключателя, рубильника, вывертывания пробок или разъема штепсельного соединения.

Если отключить нельзя	Воспользоваться сухим непроводящим ток предметом (деревянная палка, доска, канат) чтобы отбросить провод от пострадавшего.
Оттаскивание пострадавшего	Оттянуть за сухую одежду (полы пиджака, воротник), избегая прикосновения к открытым участкам тела и металлическим предметам.

2.2. Меры предосторожности для оказывающего помощь

Что делать	Почему это важно
Изолировать руки (диэлектрические перчатки, сухая шерстяная или прорезиненная ткань)	Предотвратить прохождение тока через тело спасающего
Встать на сухую доску, резиновый коврик или другой изолирующий предмет	Исключить риск шагового напряжения
Действовать одной рукой, вторую держать за спиной или в кармане	Снизить риск замыкания цепи тока через сердце
Не прикасаться к пострадавшему без изоляции рук	Это смертельно опасно

2.3. Особый случай: пострадавший находится на высоте

При отключении электроустановки пострадавший может упасть. Необходимо принять меры, предотвращающие падение или обеспечивающие его безопасность.

3. АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

После освобождения от действия тока оценить состояние пострадавшего.

Состояние пострадавшего	Действия
Сознание отсутствует, пульс не прощупывается, дыхание отсутствует	Немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации (СЛР): 30 надавливаний на грудную клетку, 2 вдоха искусственного дыхания «рот в рот». Продолжать до прибытия скорой помощи
Сознание отсутствует, пульс и дыхание сохранены	Повернуть на живот (обеспечить проходимость дыхательных путей), голову повернуть набок, следить за состоянием до приезда медиков
Сознание сохранено, но есть жалобы	Обеспечить покой, наблюдать, не оставлять одного (состояние может резко ухудшиться в ближайшие часы)

4. ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (ОЖОГОВ)

4.1. Наложить сухую асептическую повязку на область ожога.

4.2. Не использовать мази, кремы, масла, а также одеяла и полотенца (ворсинки прилипают к ране). Использовать стерильную марлевую салфетку или чистую ткань.

4.3. При ожогах кистей или стоп проложить между пальцами свернутые бинты или ватные тампоны, чтобы предотвратить сращение тканей.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

Что сделать	Пояснение
Вызвать скорую медицинскую помощь (112, 103)	Вызов обязателен даже при удовлетворительном состоянии, так как возможны отсроченные осложнения (инфаркт, стенокардия, вторичный шок)
Эвакуация	Если нет возможности вызвать скорую, организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение (желательно лежа)
Документирование	Сообщить администрации школы о несчастном случае, зафиксировать время и обстоятельства происшествия

6. ЧЕГО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ

Запрещенное действие	Причина
Прикасаться к пострадавшему без отключения питания или без изоляции рук	Поражающий фактор продолжает действовать
Прекращать реанимацию до прибытия врача (кроме случаев явной смерти)	При электротравме часто наступает «мнимая смерть» – состояние обратимого шока
Оставлять пострадавшего без сознания на спине	Язык может запасть и перекрыть дыхательные пути
Давать пить при отсутствии сознания или жалобах на тошноту	Возможна аспирация (попадание жидкости в дыхательные пути)

7. ПРОФИЛАКТИКА (ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ)

Перед началом работы проверить исправность аппаратуры, целостность изоляции проводов, наличие заземления.

Не допускать учащихся к ремонту и включению электрооборудования без вашего контроля.

Соблюдать правила электробезопасности в кабинете информатики: не работать с оборудованием во влажной одежде и мокрыми руками.

Знать места расположения рубильников (автоматических выключателей) для экстренного обесточивания кабинета.

Иметь в кабинете аптечку с набором для оказания первой помощи (стерильные бинты, пластырь, ножницы для разрезания одежды).